

正顎手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

適應症及作法：(簡述)

上下顎骨可因先天生長遺傳因素、外傷、腫瘤生長及某些影響顎骨發育之疾病等因素，而導致上下顎骨間相關位置的不協調，在臨床上表現出咬合不正、咀嚼功能不佳、顫顎關節障礙、發音不正、顏面外觀型改變、甚至呼吸道阻塞等問題，嚴重影響生活品質。若單純的齒列矯正治療無法解決問題時，就必需進行正顎手術來改善。正顎手術通常需全身麻醉且住院3-7天，術後上、下顎骨通常需固定一段時間，不易張口，需進食流體食物。內部移位之骨頭或植骨約需一年左右才能穩定。

效益：(經由手術，您可能獲得以下的效益，但醫師並不能保證您一定能夠獲得其中的任何一項；手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。)

經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。經由上述手術之施行，您可能獲得以下所列部分或全部的效益：

(1)改善顏面部外觀。(2)改善咀嚼功能。(3)改善語言功能。(4)減少呼吸道阻塞風險。(5)減少顫顎關節不適感。(6)輔助齒列矯正治療。(7)手術處置成功率

風險：(沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是可能仍然有一些醫師無法預期的風險未被列出。)

沒有任何手術是完全沒有風險的，手術結果也未必完全符合您的期望，這些風險包括術中、術後可能之暫時或永久性併發症，這些併發症，嚴重時甚至可能威脅生命。以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。醫師將會為您解釋這些可能產生的風險及處理方式。

(一)一般性併發症

(1)傷口出血。(2)傷口疼痛。(3)傷口腫脹。(4)傷口感染或癒合不良。(5)局部或全身麻醉風險。(6)因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術。(7)必要時輸血導致之不適感或感染風險(如愛滋病、肝炎等)。

(二)特殊性併發症

(1)術中大出血。

- (2)臉部皮膚瘀青。
- (3)全身性感染或敗血症。
- (4)自體骨或人工移植物部分或全部吸收、排斥、感染、壞死、移位或不良反應，嚴重時需再度手術或移除。
- (5)取移植物處(donor site)組織運動神經、感覺神經或相關功能障礙。
- (6)氣胸、呼吸困難、肺炎、肺擴張不全。
- (7)腹膜穿孔感染。
- (8)口唇閉合不全。
- (9)顏面神經傷害導致眼睛暫時或永久性閉合不全或嘴角歪斜。
- (10)三叉神經傷害導致顏面、嘴唇、下頷、牙齒或舌頭暫時或永久性麻痺感。
- (11)疤痕形成。
- (12)術後暫時或永久的開口受限。
- (13)肌肉受傷、僵硬。
- (14)顏面部皮膚癢縮。
- (15)呼吸道阻塞導致需氣管內插管或氣管切開術。
- (16)腦部傷害或腦脊髓液外漏及發炎。
- (17)鼻竇炎。
- (18)非計畫位置之骨裂開。
- (19)切骨處鄰牙的傷害或損失。
- (20)骨頭喪失。
- (21)術後咬合改變、不良
- (22)矯正骨部分復發、退位
- (23)損害矯正裝置
- (24)顫顎關節障礙
- (25)視神經傷害
- (26)長期上下顎間固定，口腔清潔不易，導致牙齒牙周炎或蛀牙。
- (27)需要附加額外手術

(28)需繼續接受矯正治療

(29)需進一步接受移除固定鐵絲、夾板、金屬板或螺絲

(30)對手術後外觀改變，主觀認知不符合預期結果。

(31)因手術時客觀因素限制，導致手術時矯正值與計畫值不相同。

(32)情緒沮喪

替代方案：如果您決定不施行這個手術或醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。這個手術或醫療處置的替代方案如下：

若您自認咀嚼功能影響不大、顏面外型可接受且並無其它不適症狀，而決定不施行這個手術，可能仍會有潛在性之風險（如下顎骨後縮而導致之呼吸道阻塞等）。

1. 不接受治療。
2. 僅靠齒列矯正治療，做有限度之牙齒排位，但對顎骨之異常幫忙有限。

醫師補充說明/病人提出之疑問及解釋:(如無，請填寫無)

1. 手術時間。
2. 術後加護病房。
3. 呼吸方式的改變（如氣管切開術等）。
4. 開口方式的改變（如上下顎間固定等）。
5. 進食方式的改變（如軟質、流質或鼻胃管進食等）。
6. 住院天數。
7. 住院費用(如自費醫材、藥物或手術項目等)。
8. 其它術後注意事項。 唇、舌、頰、牙齒及牙齦等口腔相關區域暫時或永久感覺異常或麻木 術後可能有顏面不完全對稱之風險 術後可能有顏面不完全對稱之風險

醫師已提供正顎手術說明暨同意書供病人參考，且病人對於醫師的說明均充份了解

正顎手術同意書

一、 擬實施之手術（如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋）

1. 疾病名稱： 咬合不正

2. 建議手術名稱：下顎雙側矢向劈裂骨切開手術；勒福式一級截骨術

3. 建議手術原因：改善咬合不正

二、醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項手術之相關資訊，特別是下列事項：

■需實施手術之原因、手術步驟與範圍、手術之風險及成功率、輸血之可能性。

■手術併發症及可能處理方式。

■不實施手術可能之後果及其他可替代之治療方式。

■預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀。

■其他與手術相關說明資料，已交付病人。

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

1. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

1. 檢體作為醫學研究之用。

2. 手術時間。

3. 術後加護病房。

4. 呼吸方式的改變（如氣管切開術等）。

5. 開口方式的改變（如上下顎間固定等）。

6. 進食方式的改變（如胃造瘻或鼻胃管進食等）。

7. 住院天數。

8. 住院費用（如健保部分負擔、健保病房費差額、自費醫材、藥物或手術項目等）。無

三、病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個手術的必要性、步驟、風險、成功率之相關資訊。

2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他治療方式之風險。

3. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解手術可能預後情況和不進行手術的風險。

4. 我瞭解這個手術必要時可能會輸血：我 ☒ 同意 ☐ 不同意輸血。

5. 針對我的情況、手術之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。

6. 我瞭解在手術過程中，如果因治療之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告或供日後研究之用，並且在之後會謹慎依法處理。
7. 我瞭解這個手術有一定的風險，無法保證一定能改善病情。

附註：

一、 手術的一般風險

1. 手術後，肺臟可能會有一小部份塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要
2. 抗生素和呼吸治療或其他必要的治療。
3. 除局部麻醉以外之手術，腿部可能產生血管栓塞，並伴隨疼痛和腫脹。凝結之血塊可能會
4. 分散並進入肺臟，造成致命的危險，惟此種情況並不常見。
5. 因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。
6. 手術過程仍可能發生難以預期的意外，甚至因而造成死亡。

二、 立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

三、 手術同意書除下列情形外，應由病人親自簽名：

1. 病人為未成年人或因故無法為同意之表示時，得由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽名。
2. 病人之關係人，係指與病人有特別密切關係之人，如伴侶(不分性別)、同居人、摯友等；或依法令或契約關係，對病人負有保護義務之人，如監護人、少年保護官、學校教職員、肇事駕駛人、軍警消防人員等。
3. 病人不識字，得以按指印代替簽名，惟應有二名見證人於指印旁簽名。

四、 醫療機構應於病人簽具手術同意書後三個月內，施行手術，逾期應重新簽具同意書，簽具手術同意書後病情發生變化者，亦同。

五、 手術進行時，如發現建議手術項目或範圍有所變更，當病人之意識於清醒狀態下，仍應予告知，並獲得同意，如病人意識不清醒或無法表達其意思者，則應由病人之法定或指定代理人、配偶、親屬或關係人代為同意。無前揭人員在場時，手術醫師為謀求病人之最大利益，得依其專業判斷為病人決定之，惟不得違反病人明示或可得推知之意思。

六、 醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行手術之必要者，仍應重新簽具同意書。

七、 醫療機構查核同意書簽具完整後，一份由醫療機構連同病歷保存，一份交由病友收執。

八、 見證人部分，如無見證人得免填載。